



COMMENT VA VOTRE COEUR ?

Rapport d'Évaluation du Risque Cardiovasculaire
Date : 06 March 2026

AVERTISSEMENT

Ce rapport est à titre informatif et pédagogique uniquement. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. Consultez votre médecin pour une évaluation personnalisée de votre risque cardiovasculaire.

1. PROFIL DU PATIENT

Sexe	Homme
Âge	58 ans
Poids	82 kg
Taille	175 cm
IMC	26.8 kg/m2 (Surpoids)
Tension artérielle	138/85 mmHg
Cholestérol total	5.8 mmol/L
Cholestérol HDL	1.3 mmol/L
Glycémie à jeun	1.02 g/L

2. RISQUE SCORE2 (SCORE2)

Le SCORE2 (Systematic Coronary Risk Evaluation 2) est l'algorithme de référence de la Société Européenne de Cardiologie (ESC 2021) pour estimer le risque à 10 ans d'événement cardiovasculaire majeur (décès CV, infarctus, AVC) chez les personnes sans antécédent cardiovasculaire.

5.3%

Risque à 10 ans : Élevé

Échelle de risque :



3. ÉVALUATION QUALITATIVE MULTI-FACTEURS

Cette évaluation prend en compte l'ensemble de vos facteurs de risque (mode de vie, antécédents, données médicales) pour établir un profil de risque global basé sur les données épidémiologiques internationales.

RISQUE MODÉRÉ

Score : 41/108 (38.0%)

Détail par facteur de risque :

FACTEUR	VALEUR	POINTS	JAUGE
Âge	58	7/14	
Sexe	Homme	5/5	
IMC	26.8 (Surpoids)	2/6	
Antécédents familiaux	ne_sais_pas	2/5	
Sédentarité (temps assis)	3-7h	2/5	
Activité physique	~30min	1/2	
Tabac actif	non	0/9	
Tabac passif	non	0/2	
Fruits et légumes	2-4/jour	1/3	
Ajout de sel	non	0/1	
Préparation des repas	maison	0/3	
Charcuterie/Fromage régulier	oui	3/3	
Stress	occasionnel	3/7	
Colères / hostilité	peu	1/3	
Charge familiale seul(e)	oui	2/2	
Alcool excessif	non	0/3	
Boissons énergisantes	non	0/1	
Hypertension	oui	4/10	
Cholestérol élevé	oui	5/9	
Diabète	non	0/7	
Apnée du sommeil	non	0/5	
Troubles du sommeil	oui	3/3	

VOS POINTS FORTS

- + Non-fumeur / arrêt depuis > 5 ans
- + Cuisine maison

4. RECOMMANDATIONS PERSONNALISÉES

Voici les actions prioritaires pour améliorer votre santé cardiovasculaire, classées par ordre d'impact :

1. Perdre du poids : viser un IMC < 25 réduirait votre risque cardiovasculaire (HR 1.26, Lancet 2014).
2. Renseignez-vous sur vos antécédents familiaux cardiovasculaires.
3. Limiter charcuterie et fromage : la viande transformée augmente le risque coronarien de 42% par 50g/jour (RR 1.42, Micha et al., Circulation 2010).
4. Charge familiale seul(e) : l'isolement et le stress chronique augmentent le risque CV de 29% (HR 1.29, Valtorta et al., Heart 2016). N'hésitez pas à chercher du soutien.
5. Hypertension diagnostiquée : vérifier régulièrement la tension.
6. Cholestérol élevé : chaque +1 mmol/L augmente le risque coronarien de 52% (PSC, Lancet 2007). Adapter l'alimentation et consulter.
7. Troubles du sommeil : l'insomnie chronique augmente le risque CV de 45% (HR 1.45, He et al., Eur J Prev Cardiol 2017). Consultation spécialisée recommandée, hygiène du sommeil à améliorer.

5. MÉTHODOLOGIE & RÉFÉRENCES

Algorithme SCORE2 (mode quantitatif)

SCORE2 (Systematic Coronary Risk Evaluation 2) est un algorithme développé, calibré et validé par la Société Européenne de Cardiologie (ESC) pour prédire le risque à 10 ans d'un premier événement cardiovasculaire dans les populations européennes. Le modèle utilise 5 variables : âge, statut tabagique, pression artérielle systolique, cholestérol total et cholestérol HDL.

Il est calibré pour 4 régions de risque en Europe. La France appartient à la région à bas risque. Les coefficients utilisés sont issus de la publication originale dans le European Heart Journal (2021).

Pour les patients de 70-89 ans, le modèle SCORE2-OP (Older Persons) est utilisé, avec des coefficients adaptés à cette tranche d'âge.

Formule : $Risque = 1 - S0^{\exp(LP)}$ puis calibration régionale
où LP = somme des (coefficient x variable centrée)
et S0 = survie de base à 10 ans.

Seuils de risque SCORE2 :

TRANCHE D'ÂGE	FAIBLE-MODÉRÉ	ÉLEVÉ	TRÈS ÉLEVÉ
< 50 ans (SCORE2)	< 2.5%	2.5 - 7.5%	>= 7.5%
50-69 ans (SCORE2)	< 5%	5 - 10%	>= 10%
>= 70 ans (SCORE2-OP)	< 7.5%	7.5 - 15%	>= 15%

Modèle qualitatif multi-facteurs (mode pédagogique)

Le mode qualitatif évalue 23 facteurs de risque pondérés proportionnellement au logarithme du risque relatif (ln(RR)) publié dans la littérature médicale. Les sources incluent INTERHEART (Lancet 2004, 52 pays), la Prospective Studies Collaboration (Lancet 2002, 1M adultes), l'Emerging Risk Factors Collaboration (Lancet 2010, 102 études) et d'autres méta-analyses de référence.

Les facteurs évalués couvrent : le profil (âge, sexe, IMC), l'hérédité, le mode de vie (sédentarité, activité physique, tabac, alimentation, stress, colères, alcool, sommeil) et les données médicales (HTA, cholestérol, diabète, apnée).

Chaque facteur reçoit un score de 0 (pas de risque) au maximum de sa pondération. Le score total est normalisé sur 100 et classé en 6 catégories de risque.

Pondérations des facteurs :

FACTEUR	POIDS	JUSTIFICATION
Âge	14 pts	HR ~2.5/décennie (PSC, Lancet 2002)
Hypertension	10 pts	HR 2x-4x (PSC, Lancet 2002)
Tabac actif	9 pts	OR 2.87 (INTERHEART, Lancet 2004)
Cholestérol	9 pts	OR 3.25 top quintile (INTERHEART 2004)
Stress	7 pts	OR 2.17 (INTERHEART, Lancet 2004)
Diabète	7 pts	HR 2.00 (ERFC, Lancet 2010)
IMC / Obésité	6 pts	HR 1.69 (97 cohortes, Lancet 2014)
Ancien fumeur <5 ans	5 pts	Risque résiduel ~50% (Kenfield, JAMA 2008)
Sédentarité	5 pts	HR 1.90 (AHA, Circulation 2016)
Antécédents familiaux	5 pts	HR 1.74 (EPIC-Norfolk, Heart 2011)
Sexe	5 pts	HR ~2.0 H vs F (EPIC-Norfolk 2024)
Apnée du sommeil	5 pts	HR 1.82 (Dong, Int J Cardiol 2013)

Comment va votre cœur ? - Évaluation Cardiovasculaire

Colères / hostilité	3 pts	HR 1.19-1.50 (Chida, JACC 2009)
Troubles du sommeil	3 pts	HR 1.45 (He, Eur J Prev Cardiol 2017)
Alimentation	3 pts	OR 1.43 (INTERHEART, Lancet 2004)
Alcool excessif	3 pts	RR 1.35 (Zhao, JAMA Net Open 2023)
Charge familiale	2 pts	HR 1.29 (Valtorta, Heart 2016)
Tabac passif	2 pts	RR 1.25 (He, NEJM 1999)
Activité physique	2 pts	HR 1.24 indépendant (méta-analyse 2012)
Boissons énergisantes	1 pt	Arythmie (Fletcher, JACC 2017)
Sel	1 pt	RR 1.13 (Graudal, Nutrients 2020)

Références

1. SCORE2 Working Group, ESC. European Heart Journal, 2021;42(25):2439-2454.
2. SCORE2-OP Working Group, ESC. European Heart Journal, 2021;42(25):2455-2467.
3. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention. Eur Heart J, 2021.
4. INTERHEART (Yusuf et al., Lancet 2004) - 52 pays, 27 000 sujets.
5. Prospective Studies Collaboration (Lewington et al., Lancet 2002) - 1M adultes.
6. Emerging Risk Factors Collaboration (Lancet 2010) - 102 études prospectives.
7. AHA Science Advisory (Young et al., Circulation 2016) - sédentarité.
8. Chida & Steptoe, JACC 2009 - hostilité et risque CV.
9. Valtorta et al., Heart 2016 - isolement social et événements CV.
10. He et al., Eur J Prev Cardiol 2017 - insomnie et risque CV.
11. He et al., NEJM 1999 - tabagisme passif.
12. Fletcher et al., JACC 2017 - boissons énergisantes.